

Preguntas y respuestas administración CESFAM

Proyecto Capstone Intermedio - Grupo 1

¿Podría explicarnos el procedimiento que hace a la hora de reagendar una cita médica?

Existen tres formas principales de reagendamiento: presencial, a través de una página web y por vía telefónica. Dependiendo del tipo de cita se utiliza un canal específico. Si el paciente es adulto mayor o le cuesta usar la página web, el personal realiza el trámite directamente y solo se le llama al paciente para informarle. También existen opciones de urgencia (como las de teléfono, donde se llama en la mañana para dar la cita el mismo día) y la opción presencial, donde se consulta disponibilidad en el momento.

¿Es común muchas citas canceladas o horas que deben ser reasignadas a la semana?

Más que cancelaciones formales, lo común es que los pacientes no asistan y pierdan la cita. El paciente habitualmente no es quien la reagenda por iniciativa propia, pero si se trata de una cita que necesita ser vista con rapidez (como un examen alterado), se le contacta e insiste para que acuda.

¿Qué escucha normalmente de los pacientes que se le cancelan las citas médicas?

Los pacientes suelen justificar su inasistencia por motivos personales o porque no pudieron venir, mencionando que quizás estaban enfermos. No suelen hacer reclamos agresivos ("no venga y todo"), sino que cancelan o faltan por situaciones de índole personal.

¿Qué siente a la hora de reagendar citas, considera que es un procedimiento engorroso y que le dedica mucha parte de su tiempo?

No se considera un procedimiento engorroso ni que tome exceso de tiempo, ya que en general resulta rápido. Si un paciente no asiste, se le contacta para explicarle de qué otra forma se puede extender o reagendar la cita. Además, cuando no hay disponibilidad, se pueden solicitar citas directamente por la página web o entregar números telefónicos para llamar.

¿Qué implementación piensa que podría facilitar su trabajo a la hora del reagendamiento de citas?

Ya se cuenta con herramientas tecnológicas que facilitan el proceso, como un sistema activo que envía mensajes automáticos (tipo WhatsApp) al paciente avisándole de su cita para confirmar o cancelar, y un sistema de grabadores que realiza llamadas automáticas consultando si desea asistir. Asimismo, se valora positivamente que la página web implementada recientemente (con alrededor de un año de funcionamiento) ha sido bastante rápida y eficiente en comparación con métodos antiguos.

(Nota adicional sobre controles de pacientes: para aquellos pacientes de "alto riesgo" que faltan seguido a sus controles o exámenes y se pierden del sistema, se realiza un seguimiento activo en el cual se les insiste y llama varias veces hasta conseguir que retomen y asistan a su cita).

¿Qué pasa con el tema de los controles, por ejemplo, si hay una persona que viene muy seguido y no son solamente citas sino como controles, y no viene? ¿Qué pasa con esos clientes, se pierde esa hora médica, qué pasa con los doctores?

Para los pacientes considerados de "alto riesgo", se les insiste varias veces para que asistan a sus citas o se les vuelve a reagendar hasta que acudan a su control (haciendo un "rescate" del paciente que no ha venido en un tiempo).

Perspectiva del personal sobre la optimización de procesos y tótems:

- Con base en su experiencia en el CESFAM, la funcionaria señala que cuando los usuarios llegan, deben registrarse.
- Considera que una mejora fundamental sería que al ingresar el usuario en el tótem, este pase por el dispositivo y quede registrado de forma automática en el sistema.
- Explica que actualmente una gran cantidad de su tiempo (un 60% a 70% del día) se va en registrar usuarios manualmente, por lo que automatizar este proceso liberaría al personal de esa carga repetitiva.
- Aclara que aunque muchas personas se manejan con la tecnología, siempre habrá adultos mayores u otras personas que prefieren el trato personal, por lo que el tótem automatizado conviviría con la atención presencial.
- Propone que el sistema de tótems imprima un ticket claro con los datos específicos (por ejemplo: "Carlitos, box 7, primer piso, box 20") para orientar mejor al paciente.
- Sugiere la incorporación de inteligencia artificial o guías automatizadas para que, al solicitar hora (por ejemplo, para policlínico o fonasa), el sistema pueda leer y analizar los antecedentes médicos y los últimos controles del paciente.
- Indica que actualmente ese filtro médico de revisión lo deben hacer manualmente los profesionales, y que la tecnología debería encargarse de determinar automáticamente qué tipo de control o especialista exacto necesita cada persona, evitando errores donde a veces se asignan horas con profesionales incorrectos (como nutriólogos, enfermeros o médicos generales).